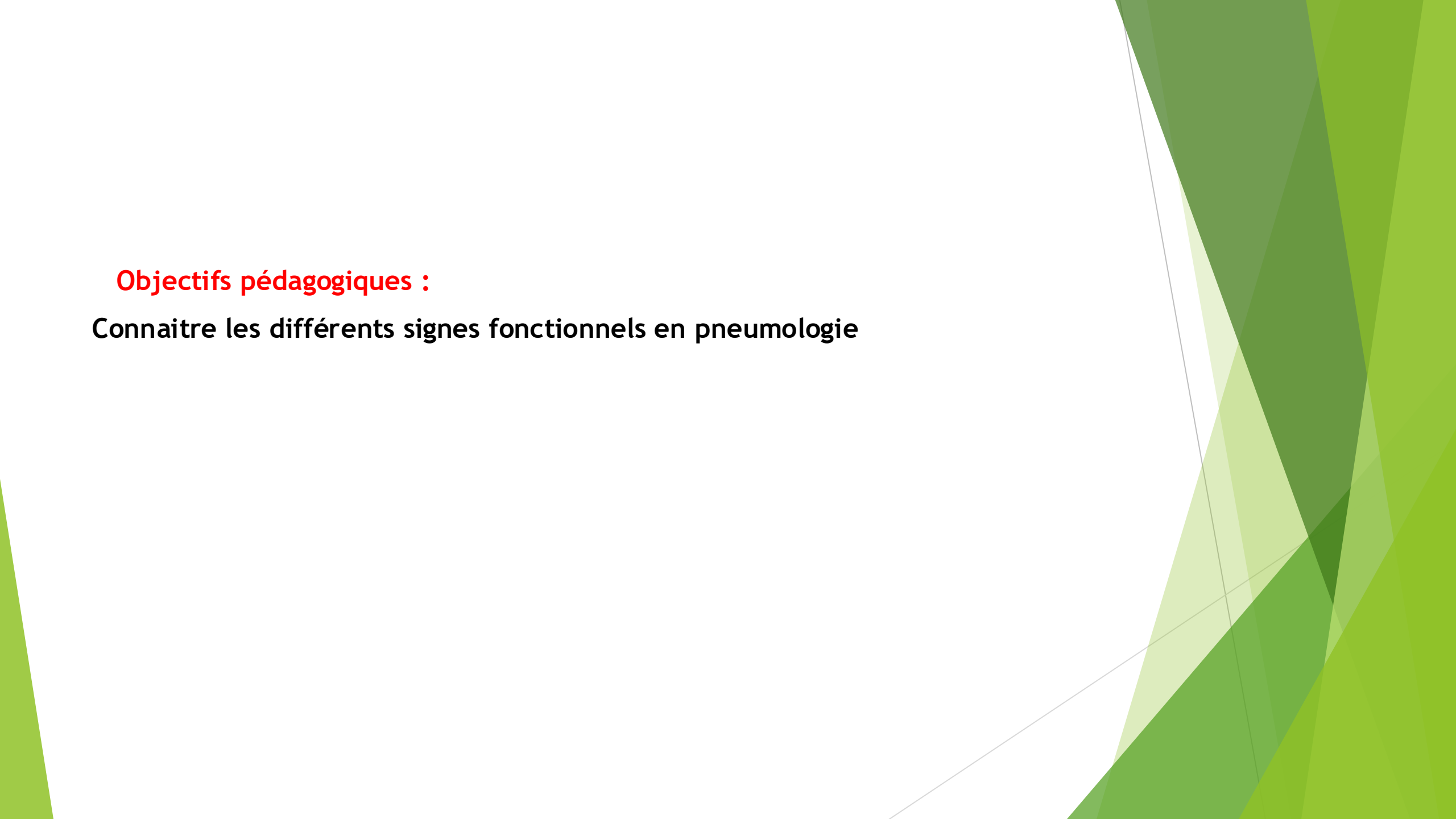


Université de Constantine
Faculté de médecine
3eme année de médecine
2024/2025

Sémiologie de l'appareil respiratoire : Douleurs thoraciques, vomique, dysphonie

Dr.A.BOUDJERIOU

The background of the slide features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Objectifs pédagogiques :

Connaitre les différents signes fonctionnels en pneumologie

I. Douleurs thoraciques

Définition :

- douleur qui siège au niveau du thorax
- d'origine extra thoracique, ou intrathoracique
- Au niveau du poumon: la plèvre et le parenchyme périphérique

Description de la douleur : Interrogatoire+++□

➤ Localisation :

- Les douleurs rétrosternales: cardiaque et médiastinale
- Les douleurs latérothoraciques: affections pleurales ou pleuro-parenchymateuses.
- les douleurs de l'épaule: d'organes sous diaphragmatiques, sommets pulmonaires.

Description de la douleur

- Irradiation :
 - douleurs pleurales: l'épaule ou l'hypochondre
 - zona et les autres douleurs neurogènes: trajet intercostal.
- Etendue: douleurs pleurales, les douleurs pariétales et psychogènes sont habituellement très localisées□
- Type de douleur : Les douleurs pleurales sont décrites comme « un coup de poignard ».

Description de la douleur

- ▶ **Intensité** : Les douleurs pleurales sont parfois intenses, L'inspiration majore les douleurs d'origine pleurale, La toux exacerbe les douleurs pleurales
- ▶ **Durée**
- ▶ **Circonstances déclenchantes**

Description de la douleur

► Les signes associés

- Signes généraux (altération de l'état général dans un contexte néoplasique)
- respiratoires : dyspnée, toux, expectoration, hémoptysie
- infectieuses : fièvre, frissons
- vasculaires : douleur d'un membre inférieur
- digestives : vomissements, dysphagie, hématurie
- neurologiques : syncope, lipothymie



► Au terme de cet interrogatoire on peut distinguer les douleurs ayant pour origine l'appareil respiratoire

► des douleurs **profondes** caractérisées par :

Elles sont exacerbées par **la toux, l'inspiration profonde et le changement de position.**

Elle réalise une **douleur unilatérale en point de côté.**

1/ Douleur d'origine pleural :

A/ Epanchement pleural aérien ou pneumothorax

- la présence d'air entre les deux feuillets de la plèvre,
- une douleur déchirante, angoisse, dyspnée et éventuellement perte de connaissance.
- une période d'adaptation en quelques minutes.

► 1/ Douleur d'origine pleural :

B/ épanchement pleural liquidien : c'est la présence de liquide dans la cavité pleurale.

La douleur varie en fonction de la nature du liquide :

Liquide inflammatoire : liquide séro-fibrineux, douleur d'intensité modérée a début progressif.

Pleurésie purulente : (empyème) si elle contient du pus, la douleur est de début brutal , d'intensité variable, signes accompagnateurs ; fièvre et altération de l'état général .

Hémothorax : du sang, post traumatique, signes accompagnateurs : pâleur, signes de choc (hypotension, pouls filant)

2/ Douleur d'origine parenchymateuse :

A / Pneumonie franche lobaire aigue :

La douleur thoracique est sous mamelonnaire a type de point de côté, fièvre, frissons, expectoration de coloration rouillée de Laennec, herpes .

B/ Embolie pulmonaire :

- Migration d'un embole le plus souvent un caillot sanguin dans l'artère Pulmonaire ou l'une de ses branches.
- début brutal, variable souvent vive, basithoracique, peut être parasternal avec irradiation en demi ceinture dans les formes massives.
- Les signes accompagnateurs: dyspnée à type de polypnée, fièvre, tachycardie.

3/ Les douleurs d'origine pariétale :

Douleur thoracique post-traumatique : ecchymose cutanée.

Zona : éruption érythémato-vésiculeuse de trajet radiculaire et causalgie

Syndrome de Tietze : douleur de articulation chondro-sternale ou chondro-costale s'accompagnant d'une tuméfaction de cette articulation.

II. La vomique

Définition :

- une variété d'expectoration, apparition brutale et le plus souvent massive :
- le rejet brusque d'une grande quantité de pus
- de liquide clair
- dans un effort de toux
- ayant pénétré suite à l'effraction dans les bronches

II. La vomique

caractéristiques sémiologiques de la vomique

1. Suivant la qualité du liquide rejeté

La vomique purulente :

- le rejet de pus provenant du poumon , de la plèvre ou de la région sous-phrénique .

La vomique eau de roche :

- le rejet d'un liquide clair, eau de roche, de saveur salée, et contenant des débris de membranes blanchâtres il peut s'accompagner d'un choc anaphylactique.
- Elle se voit lors de rupture d'un kyste hydatique intra parenchymateux dans les bronches

II. La vomique

2. Suivant la quantité de liquide rejeté :

La vomique massive :

elle revêt une allure dramatique, lors d'un effort ou d'une quinte de toux

douleur thoracique déchirante, rejet d'un flot de pus par la bouche, au milieu de quintes de toux, parfois d'efforts de vomissement.

La vomique fractionnée :

rejet de liquide le plus souvent de pus par petites quantités mais de manière répétée.

La vomique nummulaire ou masquée :

réduite à de simples crachats purulents plus ou moins nombreux, rapprochés.

II. La vomique

Ces deux derniers types sont moins caractéristiques que la vomique massive ; une vomique se caractérise essentiellement par :

- Le mode de début toujours subit.
- En cas de vomique purulente il s'agit de pus franc.
- La quantité rejetée dans les 24 heures est en général abondante.

III. La dysphonie

Il existe différentes variétés de troubles de la voix ou dysphonie :

La voix rauque ou éteinte : la laryngite diphtérique ou croup.

La voix nasonnée :

Présente en cas d'encombrement du cavum et en cas de paralysie du voile du palais.

La voix bitonale :

est une voix alternativement élevée et grave, appelée aussi « voix de fausset Elle traduit le plus souvent la paralysie d'une corde vocale.